



胰岛素瘤

作者: **B. Mark Evers**, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky

Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2024

胰岛素瘤是**胰腺**的一类罕见神经内分泌肿瘤，可分泌胰岛素，这种激素能降低血糖（葡萄糖）水平。

- 这些肿瘤原发于胰腺中产生胰岛素的细胞。
- **低血糖**引起的症状包括虚脱、虚弱、头痛和意识模糊。
- 诊断方法包括血液检查和影像学检查。
- 治疗方法是手术（在可行情况下），有时需化疗。

胰岛素瘤是一类**胰腺神经内分泌肿瘤**。诊断的平均年龄50岁。仅10%的胰岛素瘤是癌性的。

胰岛素瘤的症状

胰岛素瘤的症状由于血糖（葡萄糖）水平低（**低血糖**）而引起，发生在患者数小时未进食后（最常见于整夜禁食后的清晨）。症状包括面色苍白、虚弱、发抖和感觉心跳加快（心悸）、大汗、精神紧张和明显饥饿感。

其他症状包括头痛、意识模糊、视力异常、重心不稳、行为或思维明显改变。

低血糖甚至可导致意识丧失、惊厥和昏迷。

胰岛素瘤的诊断

- 血液化验
- 影像学检查

诊断胰岛素瘤比较困难。医生会尝试在患者有症状且未进食时进行血液检查。检查包括血糖水平和胰岛素水平。非常低的血糖和非常高的胰岛素水平常提示胰岛素瘤。由于许多患者只是偶尔出现症状，因此医生可能会要求住院。在医院，患者至少禁食48小时，有时长达72小时，并受到密切监测。在此期间，症状通常会出现，医生会做血液检查以测量葡萄糖和胰岛素水平。

如血液检查提示胰岛素瘤，须准确将肿瘤定位。影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 和内窥镜[超声](#)（将尖端带有超声探头的可视管插入小肠上部）或[正电子发射断层扫描](#) (PET)，可用于定位肿瘤。有时需要手术探查。

胰岛素瘤的治疗

- 手术切除
- 使用二氮嗪，或有时使用奥曲肽或兰瑞肽
- 有时使用化疗

胰岛素瘤的初治是手术切除，治愈率大约90%。

当胰岛素瘤不能被完全切除且症状持续存在时，使用二氮嗪或者有时使用奥曲肽或兰瑞肽等药物可帮助避免血糖降得太低。

化疗可能有助于控制肿瘤。